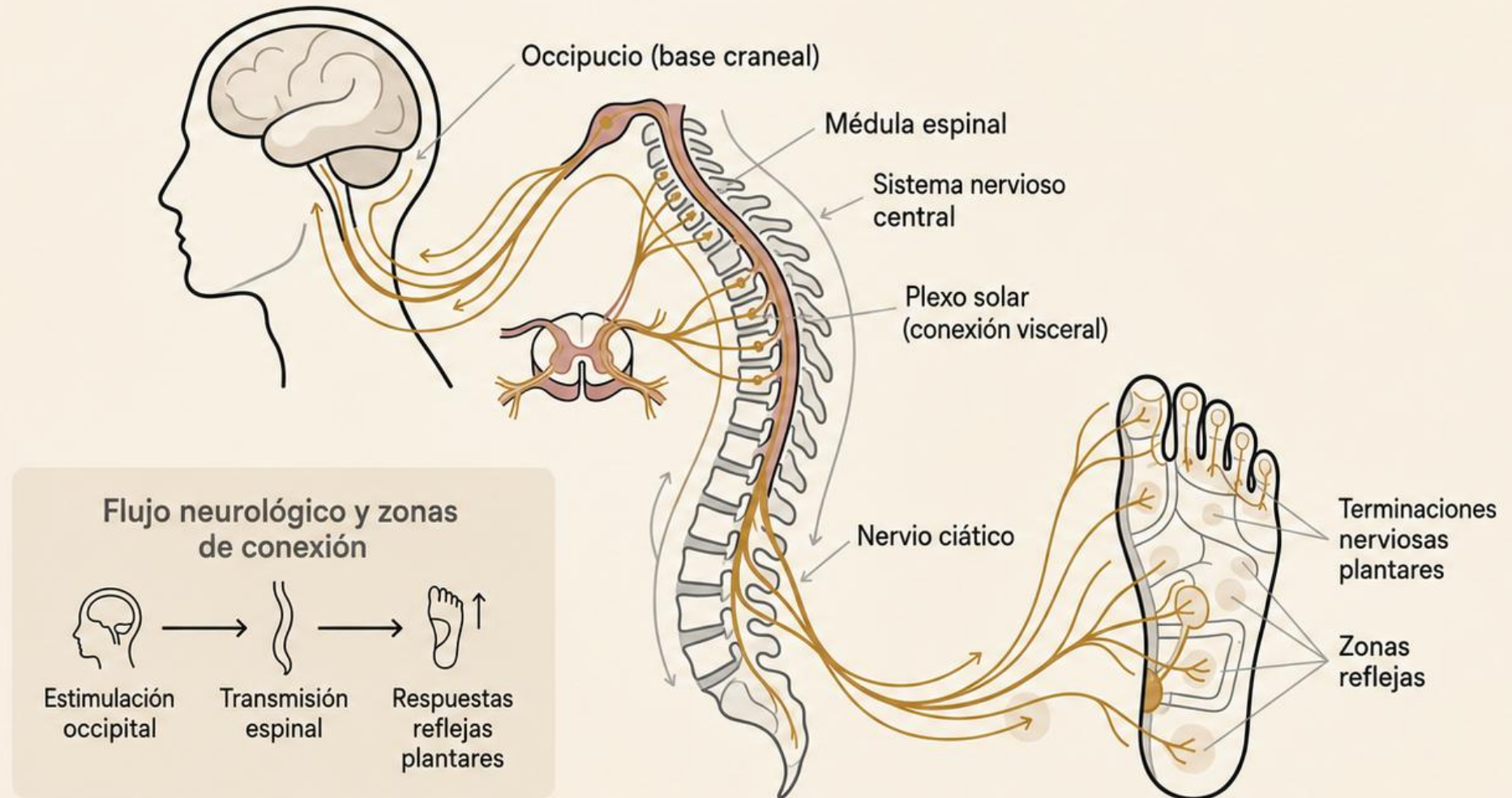


Tratamiento mediante la Reflexoterapia Occípito-Podal (ROP)

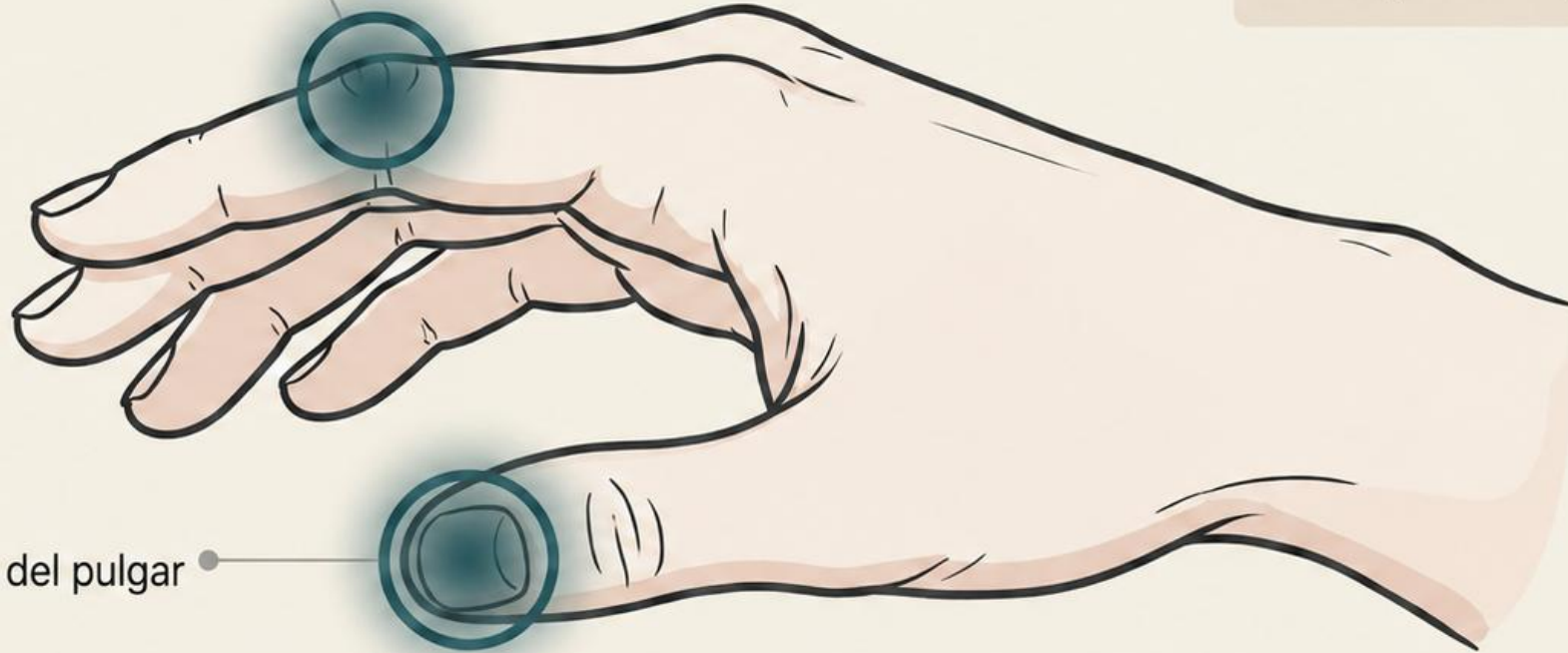
Capítulo 2 — Principios, Cartografía y Clínica



La exigencia del gesto terapéutico

Interfalángica proximal
del índice

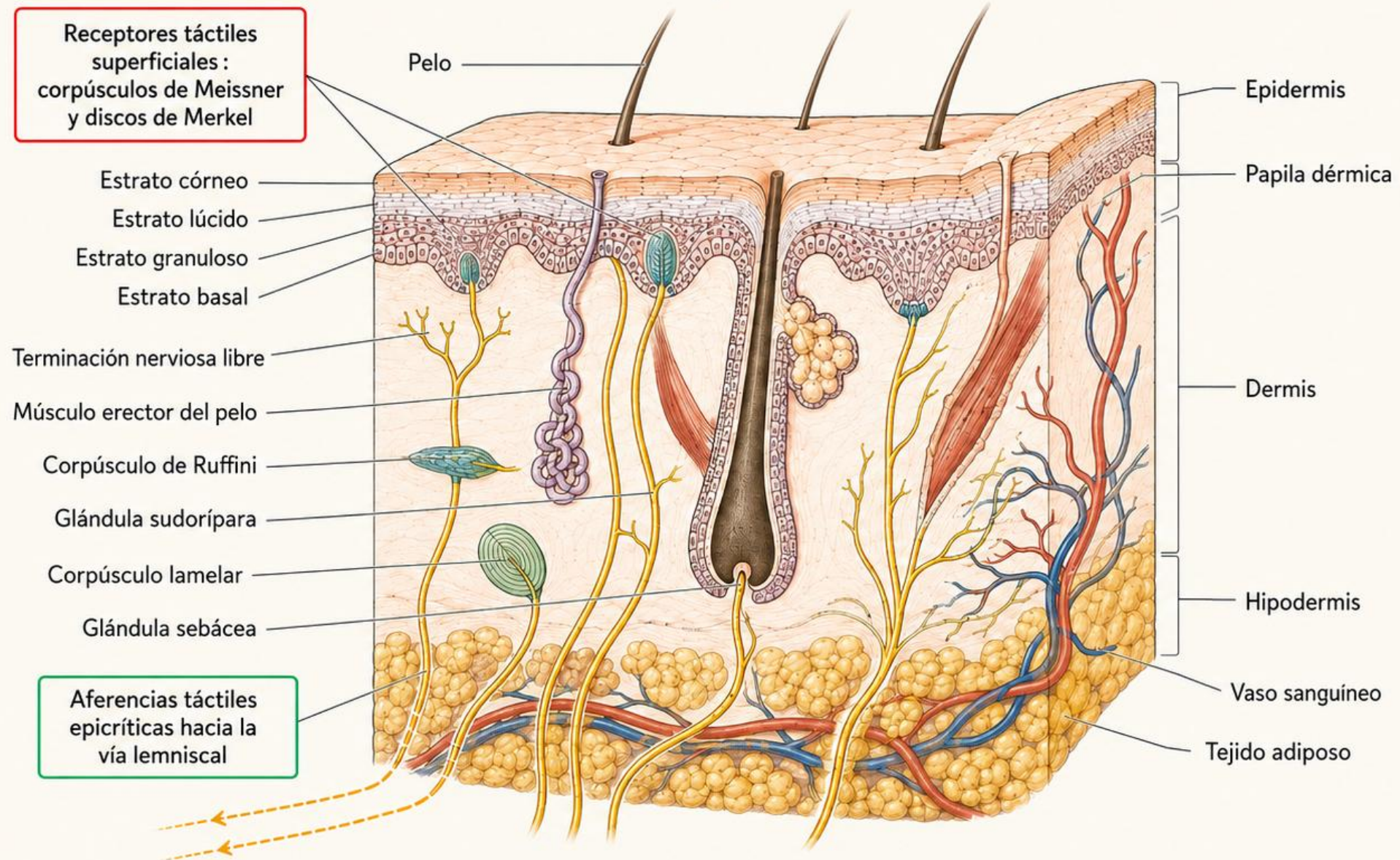
Pulpejo del pulgar



Un enfoque exclusivamente manual, sin adición de aceite ni crema, basado en la precisión de la presión epicrítica.

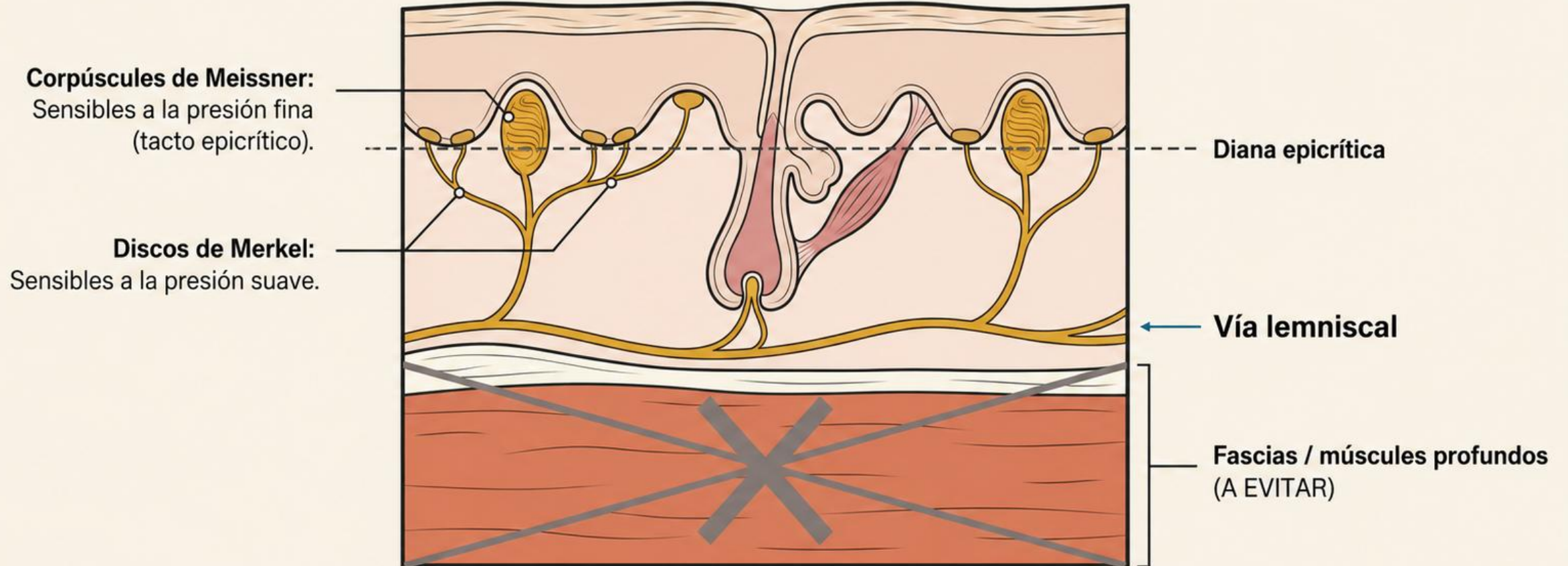
La fuerza y el amasamiento están contraindicados. Cuanto mayor sea la presión, más difícil resulta la lectura de los puntos de referencia óseos y de las zonas reflejas.

La piel



Representación esquemática de las capas de la piel, de sus anexos y de sus principales receptores táctiles superficiales.

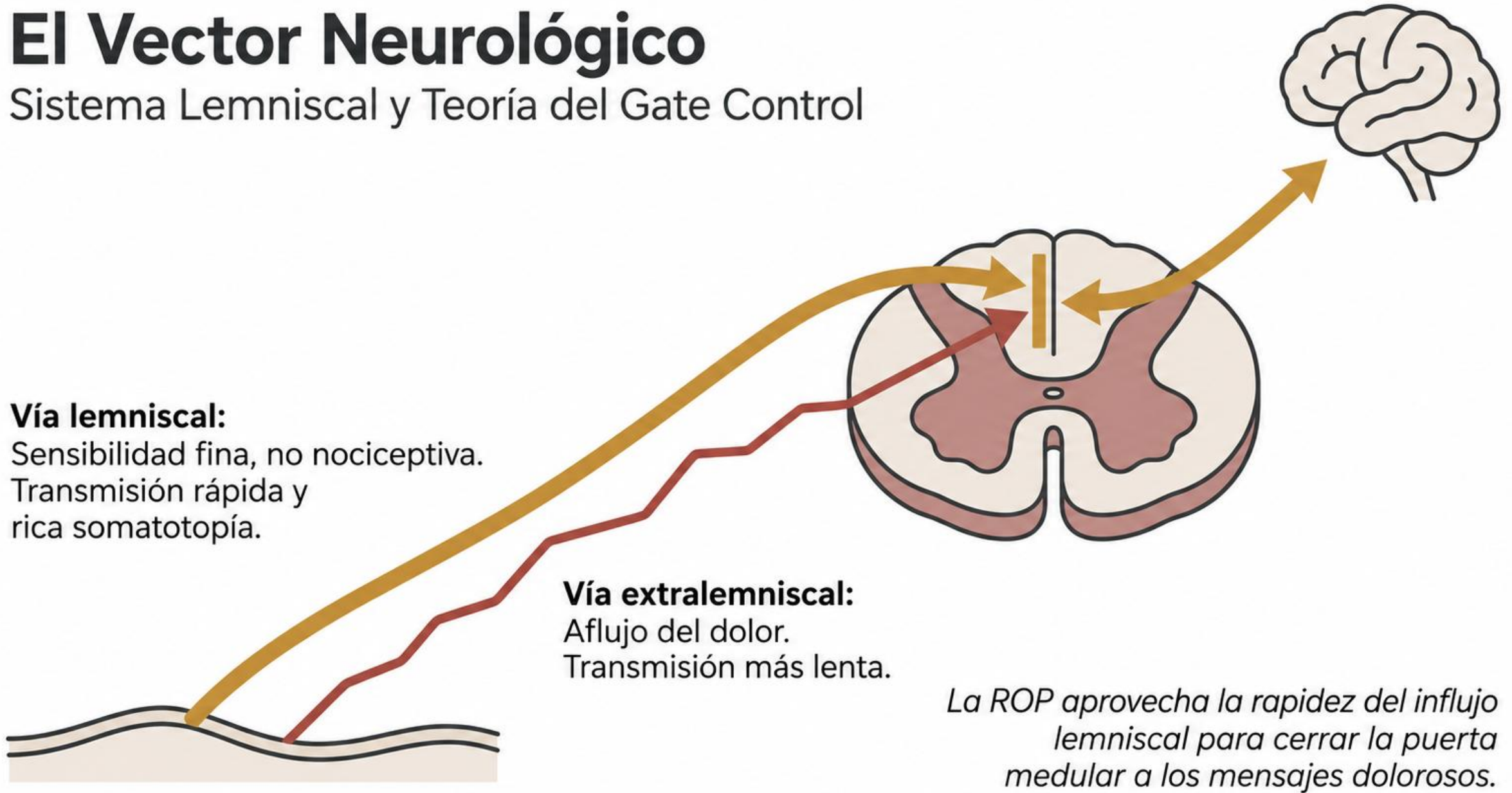
La diana tisular: Capa epidermo-dérmica



El objetivo es la deformación de la piel, identificada por la sensación de "piel de tambor".
Cuanto mayor es la presión, más desaparece la percepción de los reparos óseos.

El Vector Neurológico

Sistema Lemniscal y Teoría del Gate Control



Cronología clínica: Los tres tiempos del masaje



Tiempo del diagnóstico textural

Acción: Búsqueda de rugosidades, densificaciones y pérdidas de deslizamiento.

Sensación del paciente: Sensación característica de pequeños pinchazos.



Tiempo terapéutico

Acción: Presión fina epicrítica. Movilización de la capa epidermo-dérmica.

Objetivo: Estimular los mecanorreceptores (sin dolor agudo, sinónimo de sobredosificación).



Tiempo del "dejar hacer"

Acción: Tiempo de latencia posestimulación. No hacer nada.

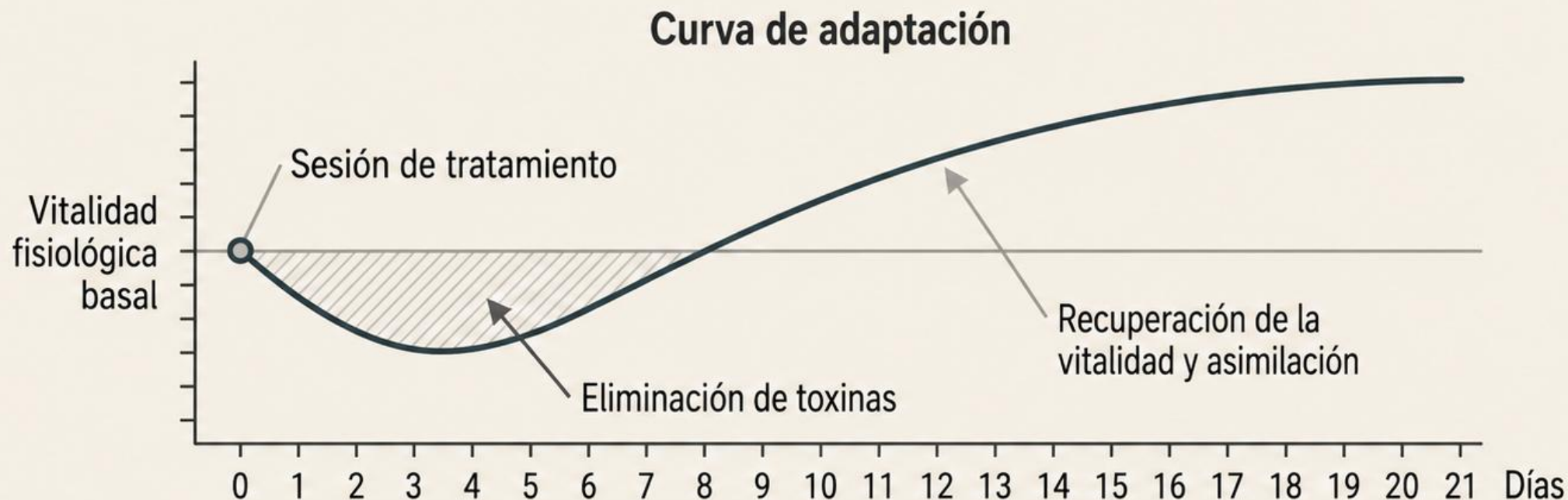
Objetivo: Permitir al organismo integrar las adaptaciones neurovegetativas.

Resultado: flexibilidad restaurada.



La Ventana de Asimilación Neurovascular

¿Por qué se requiere un intervalo de 3 semanas?



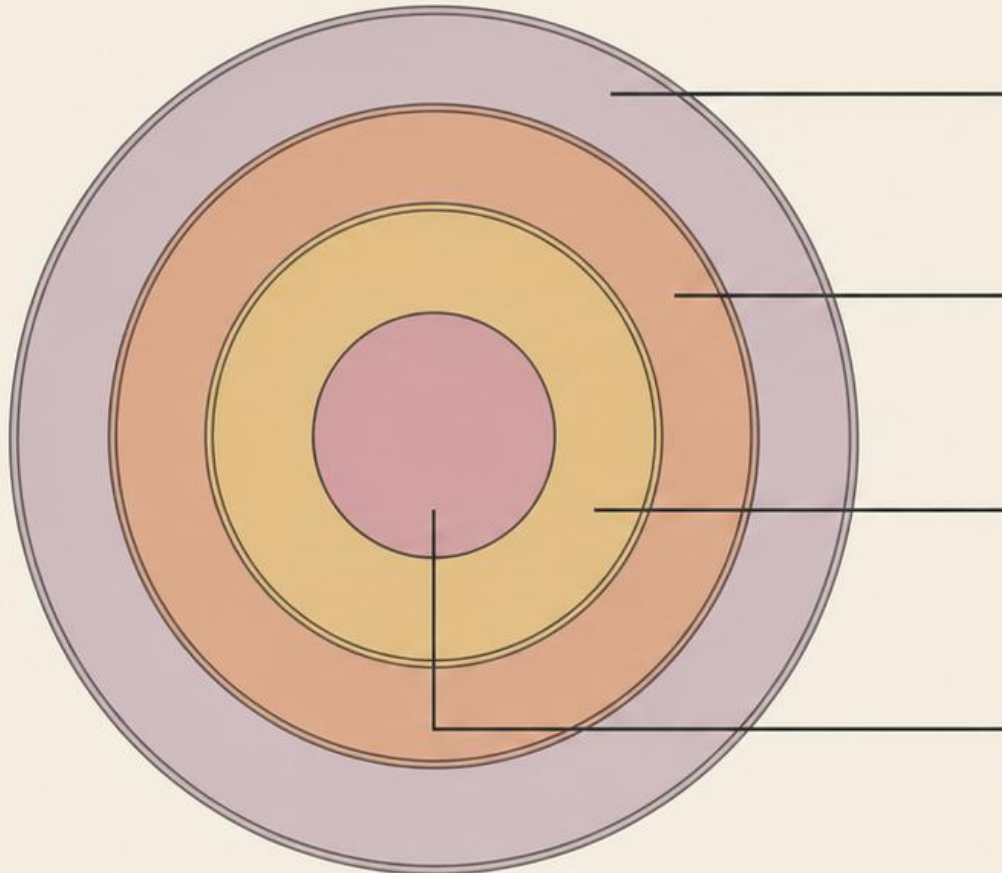
24 a 48 horas: Posibles reacciones transitorias (mialgias, fatiga, sueños vívidos). Esto refleja la respuesta al estrés positivo y la eliminación de toxinas.

Semanas siguientes: Adaptación de los sistemas inmunitario, hormonal y psíquico.

Las sesiones de tratamiento demasiado próximas no dejan tiempo suficiente a los procesos neurovasculares y estructurales para restablecer la fisiología en las vísceras. Por lo general, tres sesiones son suficientes.

Jerarquización del Plan de Tratamiento

No existe un protocolo inmutable en un enfoque holístico.



1. Urgencias y Secuelas: Condiciones postraumáticas, cirugía, infección (prioridad inmediata).

2. Fijaciones Dominantes: Identificadas mediante la anamnesis y las pruebas de escucha global/local.

3. Esfera Psicoemocional: Traumatismos antiguos reprimidos (amígdala / hipocampo).

4. Contexto General (SGA): La historia completa de las adaptaciones del individuo.

Cartografía de intervención

Las tres esferas reflejas occípito-podales

1. Síndrome General de Adaptación (SGA)

Occipucio-C1-C2, nervio vago (X), hoz del cerebro, MRP, sistema venoso.

Objetivo: Apoyar la regulación neurovegetativa global.



3. Sistema Límbico

Amígdala, hipocampo, ínsula.
Equilibrio cerebro-vísceras.

Objetivo: Integrar la dimensión del estrés y la memoria corporal.

2. Síndrome Locorregional

Plexo prevertebral, plexos somáticos, cavidades abdominal y pélvica.

Objetivo: Tratar los circuitos viscerosomáticos.

Dianas Anatómicas I: Síndrome General de Adaptación

Apoyar la regulación neurovegetativa antes de tratar el tejido local.

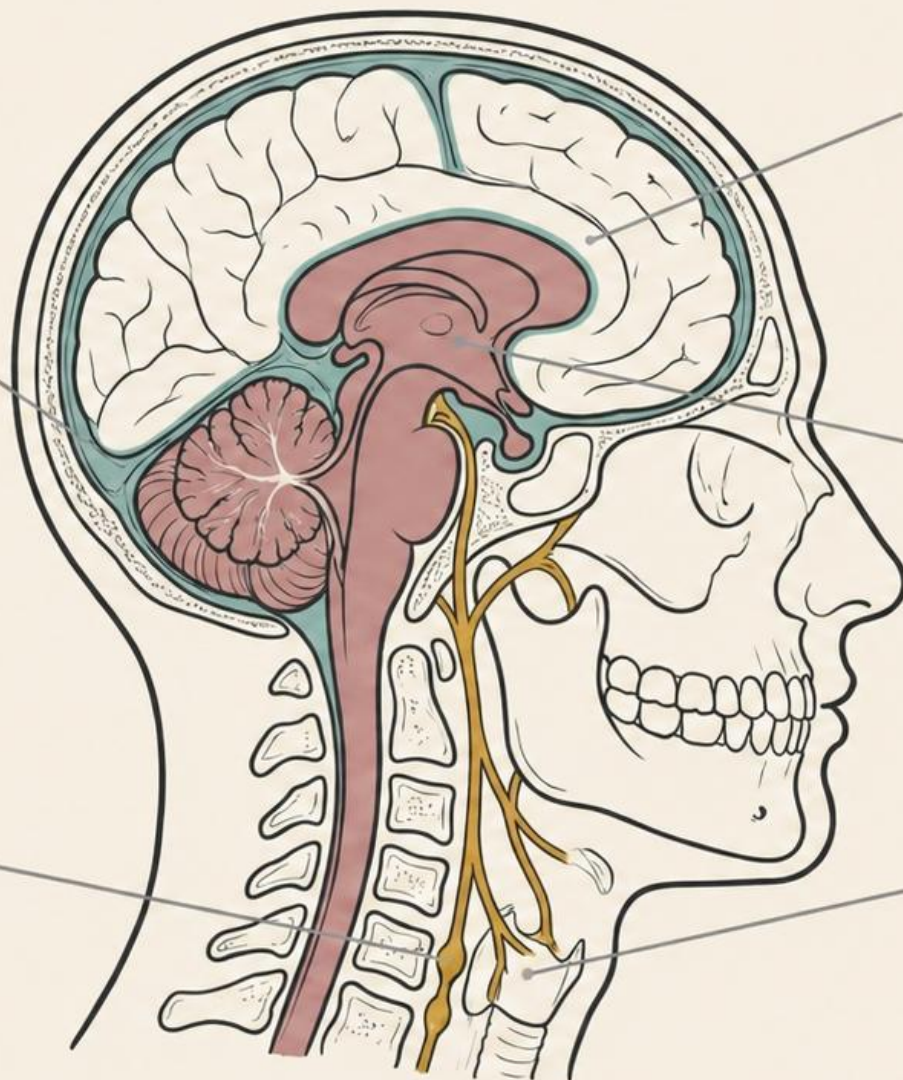
MRP (Mecanismo Respiratorio Primario): Occipucio-C1-C2, nervios craneales V, X, XII, hoz del cerebro.

Líquido cefalorraquídeo: Sistema venoso, compresión del IV ventrículo, sincronización SSB-S2.

Centros superiores: Diencefalo, tronco encefálico, hipófisis.

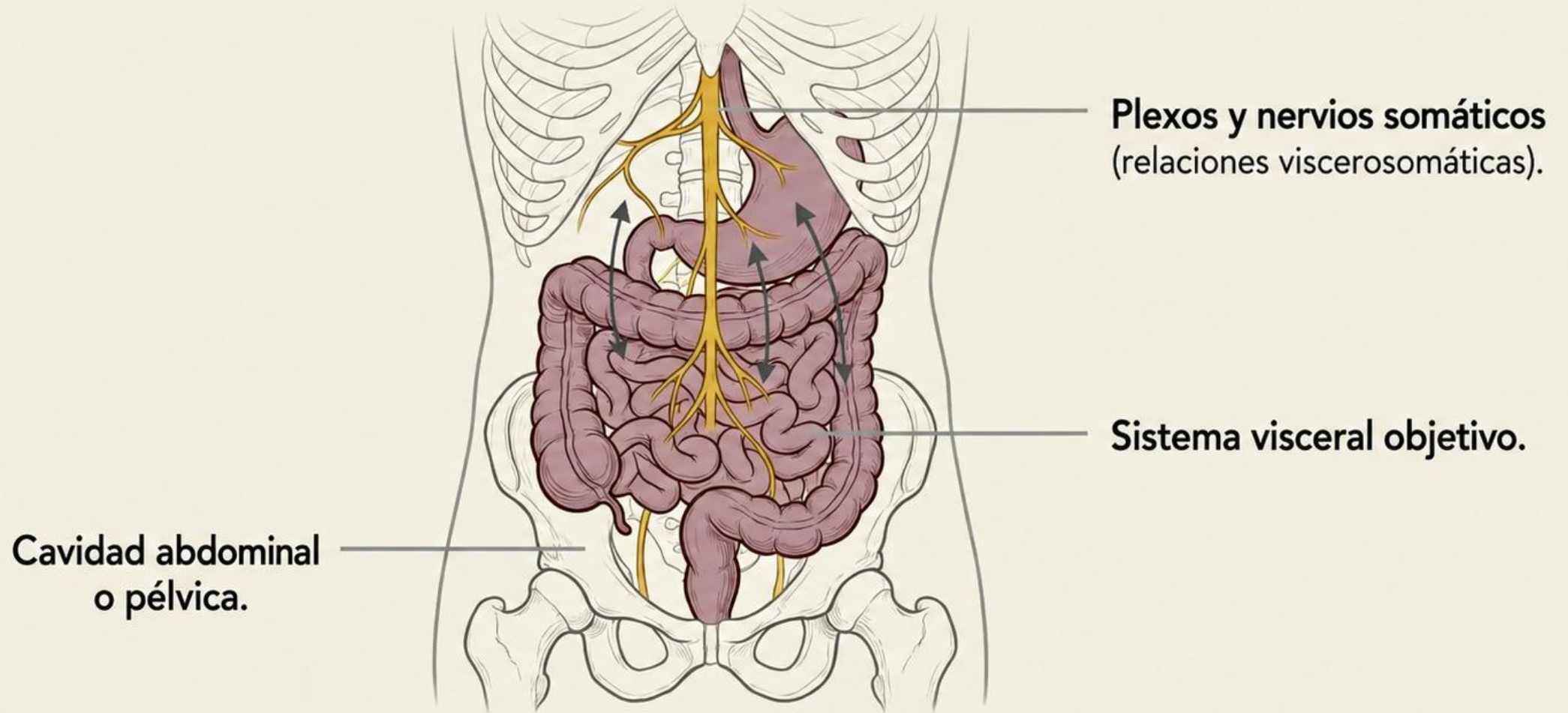
Inervación simpática: Columna vertebral, cadena ganglionar laterovertebral.

Sistema neurovegetativo: Nervio vago (foramen magno/yugular, hiato esofágico), parasimpático pélvico.



Objetivo II: Síndrome Locorregional

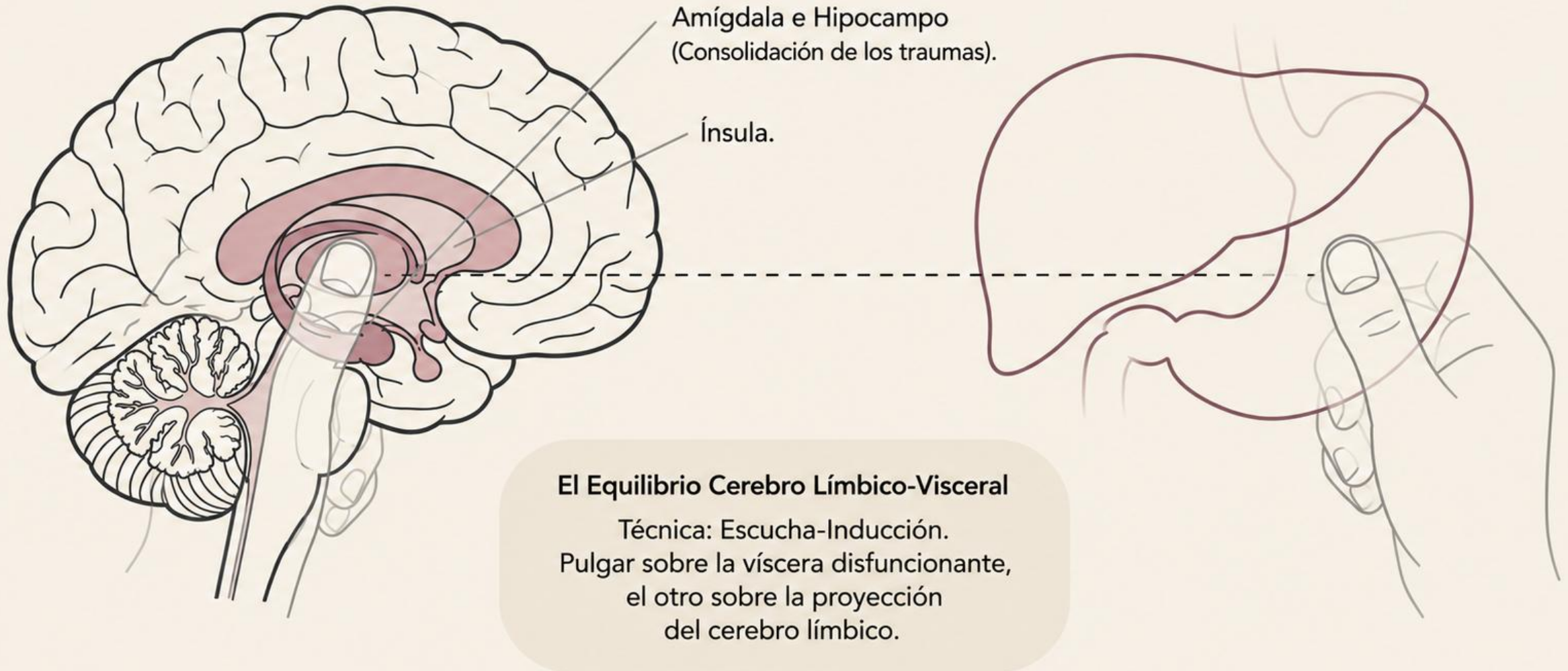
Tratamiento de los bucles relacionados con la región sintomática.



El objetivo es liberar las fijaciones locales de la cavidad correspondiente para restaurar la movilidad tisular y romper el bucle neurovegetativo mantenido por la disfunción.

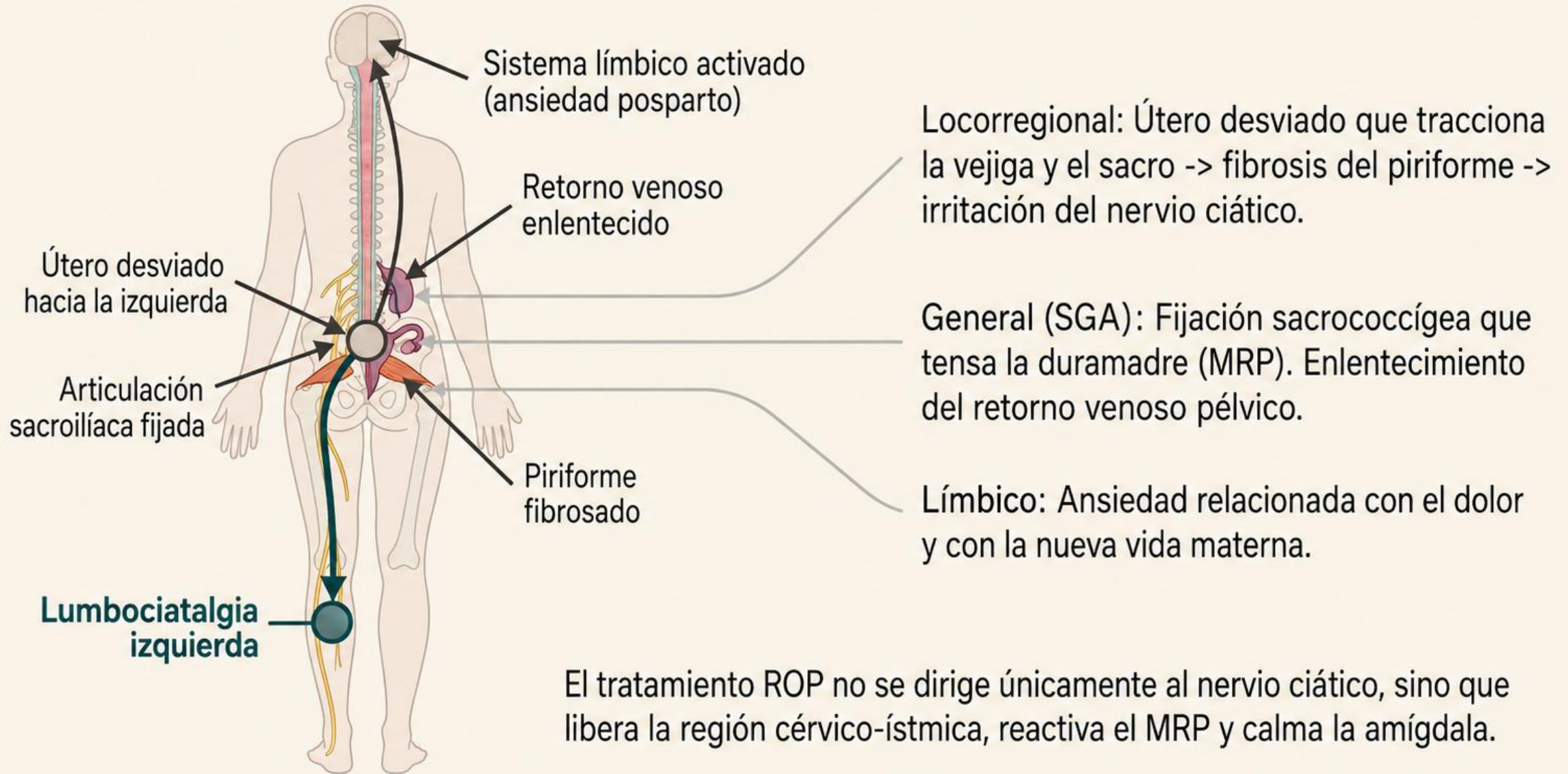
Objetivo III: Sistema Límbico

Integración de la memoria corporal.



Aplicación clínica: Lumbociatalgia posparto

Paciente primípara, dolor exacerbado durante la menstruación, parto prolongado.



El plan de tratamiento ROP dirigido para la Señora X

Pilar 1: Síndrome general — fundamento

- Mecanismo Respiratorio Primario (MRP)
- Diencéfalo y Tronco encefálico
- Eje hormonal: Hipófisis, Suprarrenales
- Retorno venoso: Hígado, Riñón izquierdo
- Columna vertebral

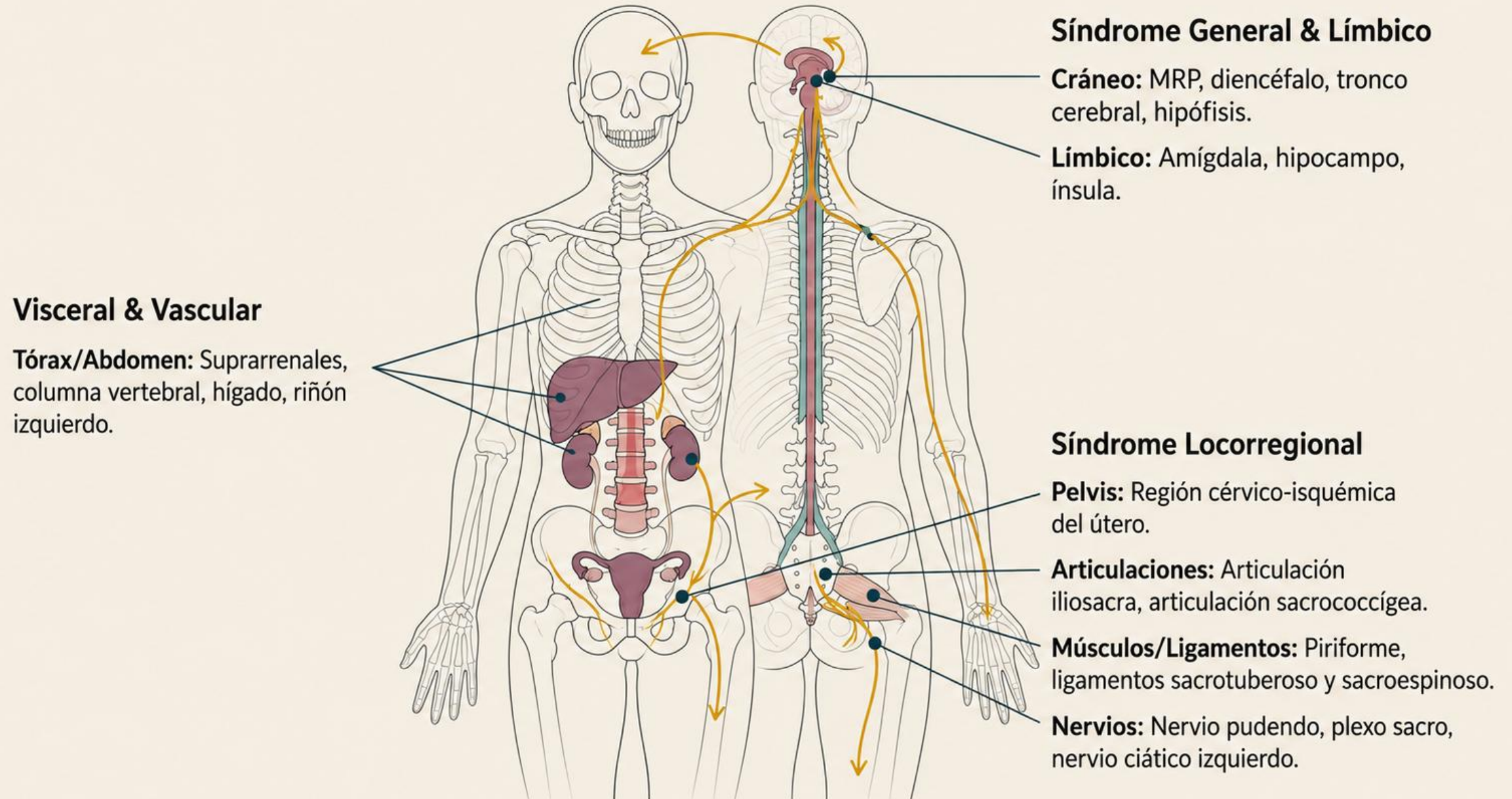
Pilar 2: Síndrome locorregional — mecánico

- Región cérvico-isquémica del útero
- Articulaciones pélvicas (sacroilíaca, sacrococcígea)
- Músculo piriforme y ligamentos sacrotuberoso/sacroespinoso
- Nervio pudendo y plexo ciático izquierdo

Pilar 3: Sistema límbico — integración

- Amígdala
- Hipocampo
- Ínsula

Plan de Tratamiento ROP (Caso de la Sra. X)



Indicaciones terapéuticas: El ámbito de los trastornos funcionales reversibles

La ROP destaca en los desequilibrios del sistema vasculonervioso que aparecen antes de la enfermedad, cuando la alteración anatómica tisular aún no se ha iniciado.



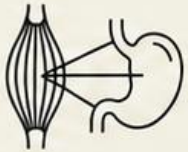
Dolores musculoesqueléticos: Lumbalgias, cervicalgias, tensiones crónicas sin afectación estructural importante.



Secuelas traumáticas: Trastornos osteomusculoarticulares o afectaciones reversibles de los nervios espinales y craneales.



Disfunciones viscerales: Bucles neurovegetativos y fijaciones tisulares que impiden la motilidad de los órganos.



Trastornos somatoviscerales: Dolores referidos entre el soma y las cavidades viscerales metaméricas.



Terreno neurovegetativo: Estrés emocional, ansiedad y desregulación del Síndrome General de Adaptación.

Gobernanza Clínica: Seguridad y Límites

✓ Indicaciones (Cuidados Funcionales)	+ Signos de Alarma (Remisión Médica Requerida)
Patologías reversibles y extracelulares.	Dolor no mecánico, peor por la noche.
Dolores musculoesqueléticos y secuelas de traumatismos.	Dolor torácico atípico, disnea.
Disfunciones viscerales y desequilibrios neurovegetativos.	Sangre en orina/heces, fiebre, pérdida de peso inexplicada.
Estrés emocional y ansiedad.	Déficit neurológico (trastornos de esfínteres/sensitivos).
Apoyo integrativo (p. ej., limitación de los efectos iatrogénicos postquirúrgicos).	

Primum non nocere. Toda sospecha de patología orgánica impone la reorientación médica.

Acompañamiento Global del Paciente



Reposo y Recuperación (RRP):

Evite el sobreesfuerzo físico a lo largo del día.



Salud Mental: Conviértase en el actor de su salud, cultive pensamientos positivos, vida social enriquecida.

« Antes de intentar curar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo han enfermado. »

— Hipócrates



Estilo de Vida e Higiene:

Alimentación saludable, hidratación adecuada, actividad física regular.



Autoobservación: Registre la evolución para su próxima consulta (dolor 0-10, sueño, tránsito, energía). El seguimiento objetivo guía la toma de decisiones y jerarquización futura.